

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

SVT • Tle D

Pratique du secourisme pour la prévention des accidents cardio-vasculaires

Module II : L'Éducation à la Santé — Le secourisme

Cette fiche évalue votre capacité à analyser des situations d'urgence, à ordonner les gestes de premiers secours et à justifier vos choix selon les protocoles en vigueur au Cameroun.

EXERCICE 1 Arrêt cardiaque au stade Omnisports

Lors de la finale de la Coupe du Cameroun à Yaoundé, un supporter de 45 ans s'effondre brutalement dans les gradins. Il ne réagit pas aux stimulations verbales et tactiles, ne respire pas (absence de mouvements thoraciques). Un témoin a déjà alerté les secours (112) et un DAE est disponible à 50 m.

1. Citez les deux critères cliniques majeurs confirmant l'arrêt cardiaque chez cette victime.
2. Décrivez la séquence exacte des gestes de RCP (Réanimation Cardio-Pulmonaire) à réaliser avant l'arrivée du DAE, en précisant la fréquence, la profondeur et le ratio compressions/insufflations.
3. Le DAE arrive. Après mise en place des électrodes, l'appareil annonce : « Choc recommandé ». Détaillez la procédure de sécurité à respecter impérativement avant d'appuyer sur le bouton de choc.
4. Le DAE délivre le choc et annonce « Aucun choc recommandé, reprenez la RCP ». Quelle conduite tenir immédiatement après ce message ?

EXERCICE 2 Étouffement total : trois profils, trois prises en charge

Dans une buvette du quartier Mvog-Ada à Yaoundé, trois clients présentent simultanément une obstruction totale des voies aériennes (incapacité à parler, toux inefficace, signe de la pince universelle) : Cas A : nourrisson de 8 mois (8 kg) ; Cas B : femme enceinte de 34 SA d'aménorrhée ; Cas C : homme adulte de 85 kg.

1. Pour chaque cas, indiquez la technique de désobstruction préconisée en première intention (nom précis) et justifiez brièvement le choix anatomique ou physiopathologique.
2. Pour le Cas B, expliquez pourquoi la manœuvre de Heimlich classique (compressions abdominales) est contre-indiquée et décrivez le positionnement exact des mains pour l'alternative.
3. Pour le Cas A, la victime devient inconsciente malgré vos tentatives. Quelle est la

conduite à tenir immédiate ? (Ordonner les 3 premières actions).

EXERCICE 3 Perte de connaissance dans un car de transport interurbain

Sur la route Douala-Bafoussam, un passager de 60 ans perd connaissance brutalement. Il respire normalement (14 min^{-1}), son pouls radial est présent et régulier. Le véhicule est à l'arrêt sur le bas-côté.

1. Citez les trois critères cliniques définissant la Perte de Connaissance (P.C.) simple (sans arrêt cardiaque).
2. Réalisez la mise en Position Latérale de Sécurité (P.L.S.) : décrivez les quatre étapes clés de la technique du « bras en équerre » pour tourner la victime vers vous, en insistant sur la protection de la tête et l'ouverture des voies aériennes.
3. Une fois en P.L.S., quels sont les trois paramètres vitaux à surveiller en continu jusqu'à l'arrivée des secours ? Précisez la fréquence de réévaluation.
4. La victime vomit abondamment en P.L.S. Quelle action immédiate devez-vous effectuer pour prévenir l'inhalation ?

EXERCICE 4 Analyse d'un algorithme décisionnel et empathie

Vous découvrez une personne allongée au sol devant l'entrée de l'Hôpital Central de Yaoundé. Le document ci-dessous résume l'algorithme simplifié « PAS » (Protéger, Alerter, Secourir) adapté.

Étape	Actions Clés
1. Protéger	Balises, sécurité té-moin/victime, coupure contact si véhicule.
2. Examiner	Conscience ? Respiration ?
3. Alerter	112 / 119 : Où ? Qui ? Quoi ? Combien ? État ?
4. Secourir	Selon bilan : RCP+DAE / PLS / Désobstruction / Hémorragie.

1. La victime ne répond pas, mais respire bruyamment (ronflement). Sur la base du tableau, quelle case de l'algorithme (Étape 2) vous oriente vers la P.L.S. et non vers la RCP ? Justifiez.
2. Lors de l'alerte (Étape 3), l'opérateur vous demande : « La victime respire-t-elle ? ». Vous répondez « Oui, mais difficilement ». L'opérateur vous dit : « Ne la bougez pas,

on arrive ». Critiquez cette consigne au regard du risque d'obstruction des voies aériennes par la langue.

3. La victime reprend conscience, est très angoissée et refuse l'hôpital. En tant que secouriste, formulez une réponse verbale adaptée (empathie, information, non-contrainte) pour favoriser son acceptation des soins.

EXERCICE 5 Gestion d'une urgence complexe : enchaînement des pathologies

M. Kamga, 68 ans, hypertendu connu, dîne chez lui à Douala. Il se lève, tousse violemment, attrape sa gorge (signe de la pince), devient cyanosé, puis s'effondre au sol, inconscient et apnéique.

1. Identifiez la pathologie initiale (avant l'effondrement) et la pathologie secondaire (après l'effondrement).
2. Ordonnez chronologiquement les actions suivantes en numérotant de 1 à 6 :
 - A. Débuter les compressions thoraciques (30 compressions).
 - B. Pratiquer 5 claques inter-omoplatiques puis 5 compressions abdominales.
 - C. Vérifier la conscience et la respiration.
 - D. Alerter le 112 (ou demander à un témoin).
 - E. Protéger la zone (éloigner la table, chaises).
 - F. Mettre en place le DAE si disponible.
3. Après 2 min de RCP efficace, le DAE indique « Choc délivré » puis « RCP ». La victime reprend une respiration bruyante et bouge les bras. Quelle position lui faire prendre ? Justifiez.